

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PERAWATAN METODE KANGGURU		
	No.Dokumen 431.2/I-SPO/NEO/V/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 10 Oktober 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M. Kes	
Pengertian	Perawatan pada bayi BBLR atau prematur dengan memberikan kontak langsung antara kulit bayi dengan kulit ibu/atau pemberi PMK (<i>skin to skin contact</i>) selama minimal 60 menit.		
Tujuan	1. Menjaga kestabilan suhu tubuh bayi (mencegah hipotermia) 2. Mendorong pemberian ASI eksklusif 3. Meningkatkan durasi dan kualitas tidur bayi 4. Mempercepat peningkatan berat badan bayi 5. Mempererat ikatan batin (<i>bonding</i>) antara orang tua dan bayi		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Panduan Penyelenggaraan PONEK 24 jam		
Prosedur	A. Persiapan Alat : 1. Gendongan kain PMK atau kain Panjang yang bersih 2. Popok bayi/ pampers 3. Topi bayi 4. Baju ibu yang kancing depan atau baju khusus PMK 5. Termometer B. Persiapan Pasien : 1. Menjelaskan kepada orang tua terkait Tujuan dan prosedur tindakan 2. Menjelaskan hal yang mungkin terjadi dan indikator keberhasilan 3. Pastikan ibu/ayah sudah mandi, kuku pendek, dan tidak menggunakan perhiasan di area dada/perut C. Persiapan Lingkungan Mengatur lingkungan yang aman dan nyaman D. Langkah-langkah 1. Cuci tangan 6 langkah sesuai standar 2. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir) 3. Ukur tanda-tanda vital bayi (Suhu, HR, RR) sebelum memulai 4. Buka baju bayi, kecuali popok, topi dan kaos kaki 5. Posisikan bayi di dada ibu/ ayah secara tegak (vertikal) di antara kedua payudara 6. Posisi Kepala: Palingkan kepala ke satu sisi (kanan/kiri) dengan posisi sedikit menengadah (<i>extensi</i>) agar jalan napas terbuka 7. Posisi Kaki: Kaki bayi ditekuk dalam posisi menyerupai		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PERAWATAN METODE KANGGURU		
	No.Dokumen 431.2/I-SPO/NEO/V/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	"posisi kodok" (<i>frog position</i>) - Posisi Tangan: Tangan bayi dalam posisi fleksi di depan dada - Ikatkan kain gendongan dengan cukup kencang agar bayi tidak merosot saat ibu bergerak, namun tidak menghambat pernapasan bayi. Perut bayi tidak boleh tertekan (posisi di sekitar epigastrium ibu) - Minta ibu memakai baju luar atau menyelimuti bayi untuk menjaga kehangatan tambahan - Instruksikan ibu untuk memantau pernapasan dan warna kulit bayi selama prosedur - Pakaikan topi bayi - Jika PMK bersifat intermiten setelah PMK selesai bantu ibu untuk melepas ikatan gendongan dan letakkan bayi pada inkubator seperti semula. E. Evaluasi - Pantau kondisi bayi selama dan setelah asuhan berlangsung terutama tanda-tanda vital dan oksigenasi - Identifikasi tanda stress seperti bayi rewel		
Unit Terkait	<i>Neonatal Intensive Care Unit (NICU)</i> - Perinatologi		